

แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัด (Perioperative Nursing Care)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์นิชา เรืองชัยวิสุข

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์: นิสิตสามารถ

1. อธิบายวัตถุประสงค์ และประเภทของการผ่าตัดได้
2. อธิบายการตอบสนองทางด้านร่างกายต่อการผ่าตัดได้
3. อธิบายระยะของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้
4. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัดได้
5. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะขณะผ่าตัดได้
6. อธิบายการพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดทันทีที่ห้องผ่าตัดและในระยะต่อมาที่หอผู้ป่วยได้

ระยะหลังผ่าตัด

ปัญหาและการพยาบาล

ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

- ❖ ทางด้านระบบทางเดินหายใจ
- ❖ ทางด้านไหลเวียนเลือดและหัวใจ
- ❖ ทางด้านระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
- ❖ ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
- ❖ การปวดแผลผ่าตัด
- ❖ ภาวะคลื่นไส้อาเจียน
- ❖ การติดเชื้อ

ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ทางด้านระบบทางเดินหายใจ

อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน จากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ❖ เสี่ยงที่จะเกิดภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน: จากการได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ยานอนหลับ ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
- ❖ การหายใจถูกกีด: การได้ยาแก้ปวดมากเกินไปในระหว่างการผ่าตัด
- ❖ การขยายตัวของทรวงอกถูกจำกัดจากการมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด

ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ทางด้านระบบทางเดินหายใจ

แนวทางในการประเมินผู้ป่วย

ประเมินความสามารถในการหายใจได้ด้วยตนเอง: หายใจเอง หรือต้องการท่อช่วยหายใจไว้ ทางเดินหายใจไม่มีสิ่งอุดตัน โล่ง ดู Signs ของการอุดตันในระบบทางเดินหายใจ เช่น สีผิว ริมฝีปาก เล็บมือ เล็บเท้า การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้า ความตื้นลึกของหายใจ ฟังเสียงปอด

ประเมินการอุดตันของทางเดินหายใจ: การเคลื่อนไหวของผนังทรวงอก การใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจ, HR, BP, อาการกระสับกระส่าย

ประเมินอัตราการหายใจ: หากพบว่าน้อยกว่า 8-10 ครั้ง หรือมากกว่า 30 ครั้ง ควรรายงานวิสัญญีแพทย์ โดยบันทึกอัตราการหายใจทุก 5 นาที



source: wikipedia.org

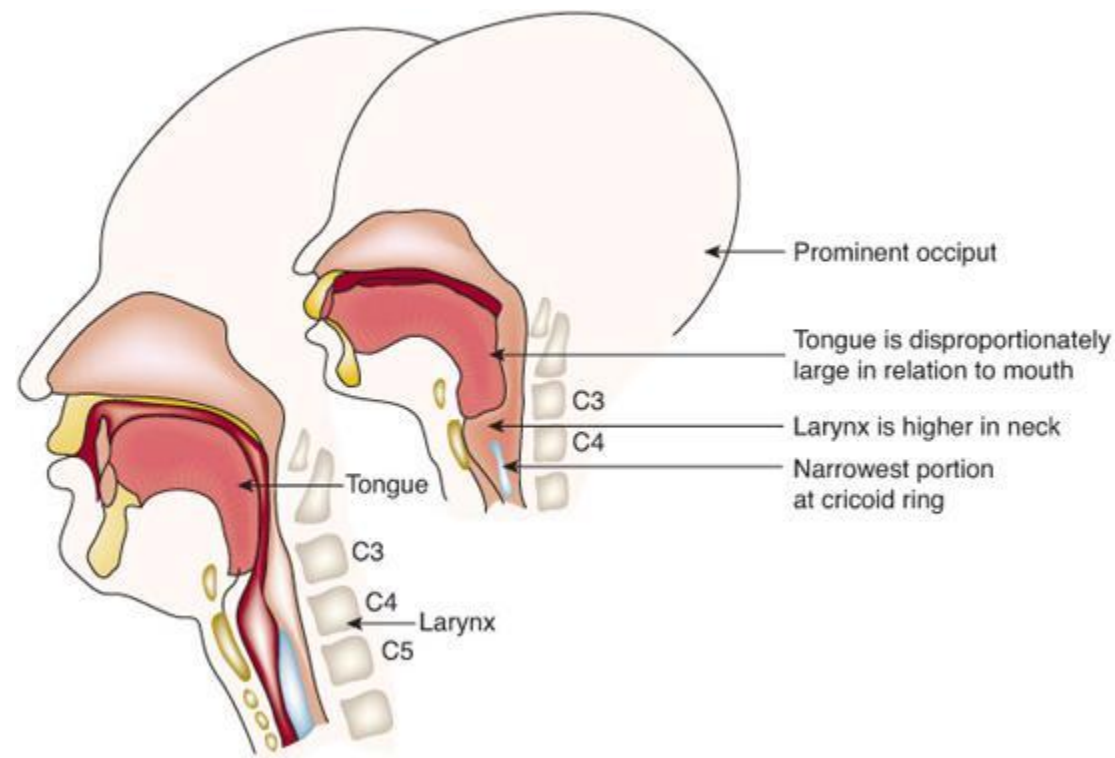
ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ทางด้านระบบทางเดินหายใจ

แนวทางในการประเมินผู้ป่วย

ประเมิน O2 saturation: โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดทั่วร่างกาย

ประเมินลักษณะของเสมหะหรือสิ่งคัดหลั่ง: ปกติเสมหะหรือเมือกจากหลอดลมใหญ่จะใส ไม่มีสี ไม่เหนียวมากเกินไป ส่วนเสมหะหรือเมือกจากปอดและหลอดลมมีลักษณะเหนียวข้น มีสีเหลืองเล็กน้อย



การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ทางด้านระบบทางเดินหายใจ

กิจกรรมการพยาบาล

- ☐ ติดตามดูแลลักษณะการหายใจ อัตราการหายใจ ติดตามดูค่าค่า Oxygen saturation
- ☐ ให้ออกซิเจนประมาณ 6-8 ลิตรต่อนาทีเมื่ออยู่ในห้องพักฟื้น และให้ต่อเนื่องที่หอผู้ป่วยอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
- ☐ การจัดท่านอน ในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีควรจัดท่านอนราบหนุนหมอนธรรมดา แต่กรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกรู้สีกตัวแต่สามารถหายใจได้เองควรจัดทำให้ผู้ป่วยนอนตะแคง หากนอนหงายก็จับศีรษะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง



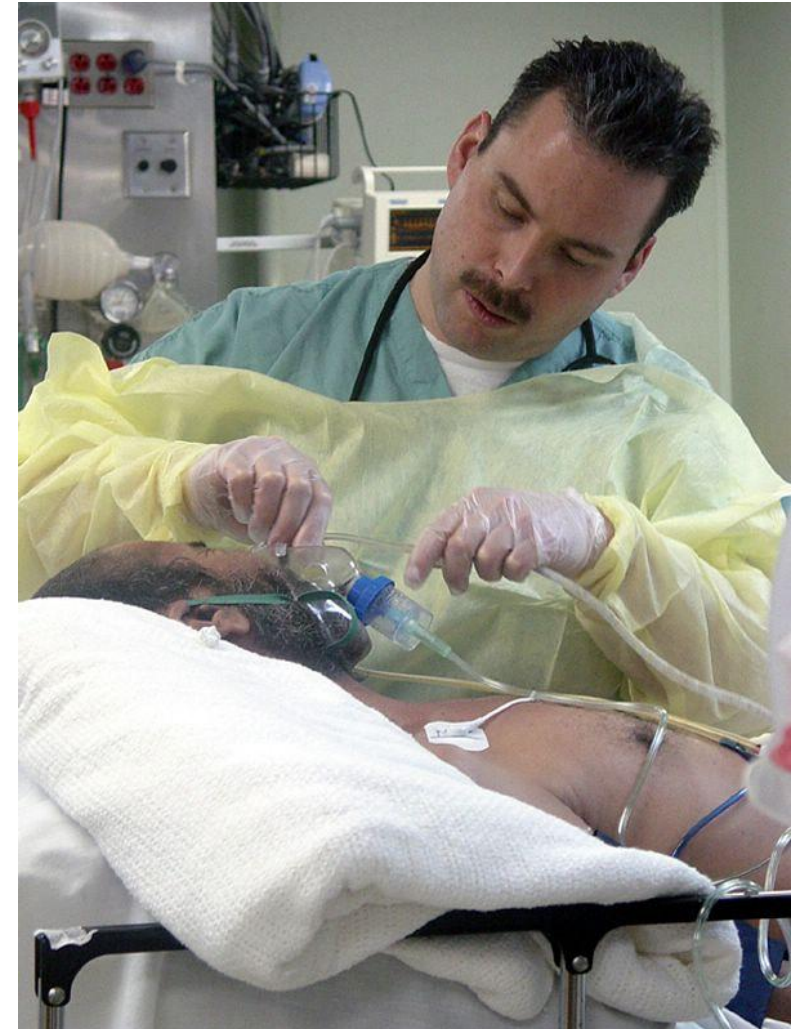
การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ทางด้านระบบทางเดินหายใจ

กิจกรรมการพยาบาล

❑ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหายใจเสียงดัง กระสับกระส่าย อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น และมีอาการเขียวคล้ำจากการขาดออกซิเจน ให้รีบทำการช่วยเหลือโดยการเคาะปอด และดูดเสมหะและสังเกตปริมาณ สี ลักษณะของเสมหะ

❑ กระตุ้นให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึก ๆ และพยายามขับไอเอาเสมหะออกมาทุก 15 นาที และหากผู้ป่วยมีอาการปวดแผลผ่าตัดควรได้รับการบรรเทาปวดด้วยการให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์



ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

:ทางด้านไหลเวียนเลือดและหัวใจ

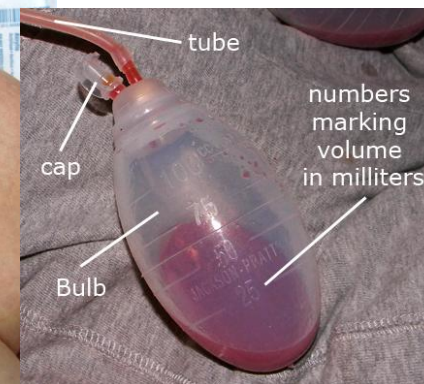
ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจลดลงหลังผ่าตัด จากสาเหตุดังต่อไปนี้

- ❖ ภาวะช็อคจากการสูญเสียเลือด (Hypovolemic shock) : ภายหลังการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมงแรกหรือ 24 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยมักมีการสูญเสียเลือดจำนวนมากออกจากหลอดเลือด
 - ปกติการเสียเลือดและน้ำหลังผ่าตัดจะอยู่ระหว่าง 100-500 มล.
 - ถ้ามากกว่า 500 มล. จะนำไปสู่ภาวะ Hypovolemic shock
- ❖ ภาวะช็อคจากหัวใจ (Cardiogenic shock): เกิดจากหัวใจถูกบีบรัดอย่างเฉียบพลัน หัวใจวาย ลิ้นเลือดอุดตันในปอด มักพบในผู้ป่วยที่มีประวัติของโรคหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- ❖ ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (Septic shock): พบในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณที่ผ่าตัดและมีการกระจายของ Toxin เข้าสู่กระแสเลือด

ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด :ทางด้านหลอดเลือดและหัวใจ

แนวทางการประเมิน

- ❖ ประเมินสัญญาณชีพ: บันทึกทุก 5 นาที และตรวจร่างกายเพิ่ม เช่น ลักษณะของผิวหนัง (ความอุ่น ความชื้น สีผิว)
- ❖ ลักษณะของแผลผ่าตัด: สังเกตจากผ้าปิดแผลว่ามีเลือดซึมออกมาหรือไม่ และบันทึกเลือดที่ออกเพิ่มขึ้น
- ❖ จำนวนและลักษณะสิ่งคัดหลั่งจากท่อระบาย: ดูชนิด (เลือดหรือไม่) บันทึกปริมาณที่ออก



ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

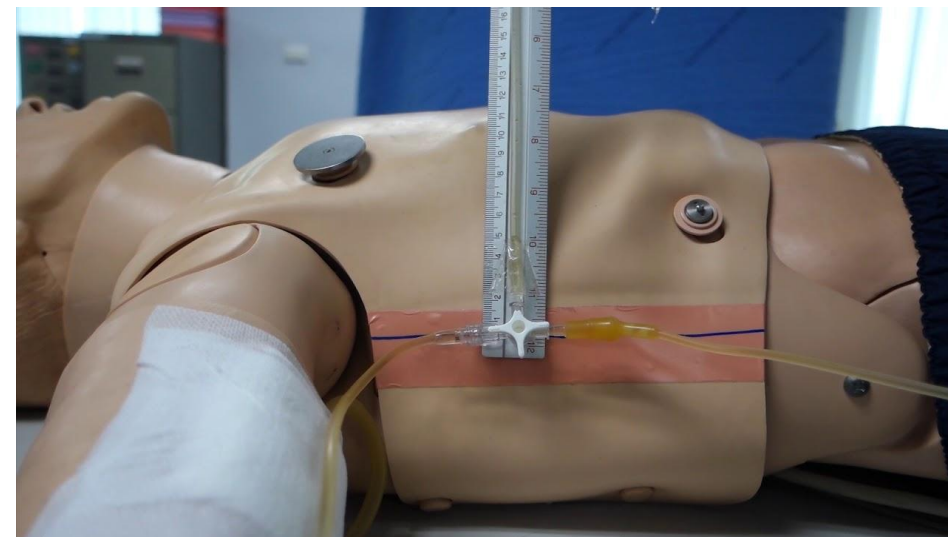
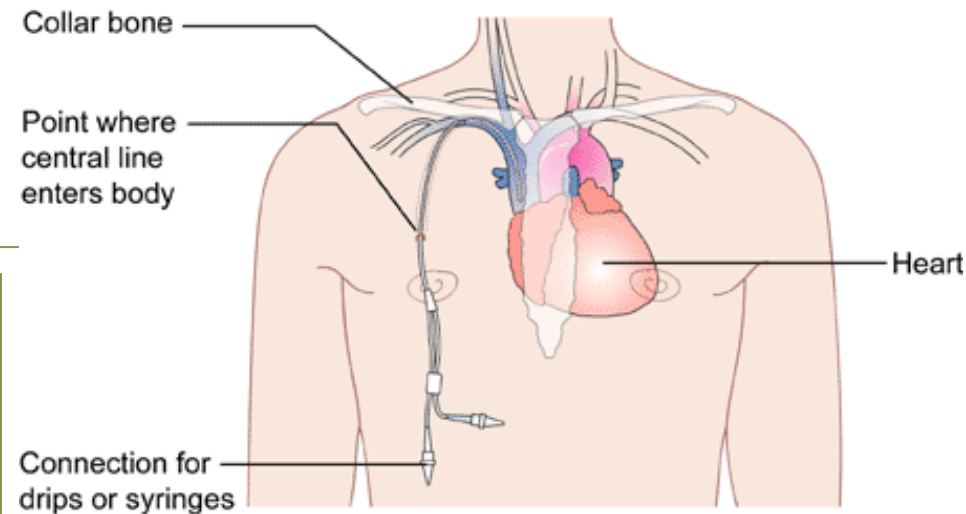
:ทางด้านหลอดเลือดและหัวใจ

แนวทางการประเมิน

ปริมาณน้ำ อาหาร เลือด และผลิตภัณฑ์จากเลือด: เปรียบเทียบระหว่างได้รับและปริมาณที่สูญเสียออกจากร่างกายทั้งหมด (ปัสสาวะ อุจจาระ สิ่งคัดหลั่ง อาเจียน ท่อระบาย) สังเกตปริมาณของเหลวในร่างกายว่ามีปริมาณมากหรือน้อย โดยดูจากการวัด Central venous pressure (CVP) หรือประเมินจากอาการของผู้ป่วย เช่น หายใจหอบ นอนราบไม่ได้ ไอมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู (Frothy sputum) ฟังปอดได้ยินเสียง Crepitation

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การติดตามค่า Hematocrit



การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด :ทางด้านหลอดเลือดและหัวใจ

- ❖ ติดตามอัตราการเต้นของชีพจร และความดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 นาที จนกว่าสัญญาณชีพจะคงที่ และในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรติดตามวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง
- ❖ ประเมินลักษณะของผิวหนัง สีของผิวหนัง อุณหภูมิและความชุ่มชื้นของผิวหนัง
- ❖ การประเมินลักษณะของแผลผ่าตัดว่าแห้งหรือมีเลือดซึมมาน้อยเพียงใด และบันทึกลักษณะ ปริมาณเลือดที่ออกจากท่อระบาย ซึ่งปริมาณที่ออกมาควรน้อยกว่า 100 มล.ต่อชั่วโมง



การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด :ทางด้านหลอดเลือดและหัวใจ

- ❖ กรณีแผลผ่าตัดมีเลือดซึมมากให้ใช้ก๊อชใหม่ทับให้แน่นโดยไม่ต้องดึงผ้าเก่าออก และพันด้วยผ้ายืด หรือหากจำเป็นต้องทำแผลใหม่ควรทำด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ และรีบรายงานให้ศัลยแพทย์รับทราบเพื่อค้นหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป
- ❖ หากผู้ป่วยมีภาวะ Hypovolemic shock ให้นิสิตศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ Shock
- ❖ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำตามแผนการรักษา ซึ่งในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีข้อจำกัดแพทย์จะพิจารณาให้สารละลาย Lactated ringer หรือ Acetar ถ้ากรณีมีการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดมากหรือค่า HCT < 30 vol% แพทย์จะพิจารณาให้เลือดทดแทน



ปัญหาและการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ทางด้านระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

อาการหายใจสั้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถกำมือ ยกแขน หรือยกศีรษะได้

❖ สาเหตุ: ได้รับยาหย่อนกล้ามเนื้อในระหว่างที่ได้รับยาระงับความรู้สึก ให้เกิดการสกดกั้นการทำงานของ Neuromuscular function ซึ่งฤทธิ์ของยาหย่อนกล้ามเนื้ออาจคงอยู่ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในห้องพักฟื้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับและโรคไตซึ่งไม่สามารถกำจัดยาออกจากร่างกายได้ตามปกติ

❖ การพยาบาล:

- ประเมินการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยการประเมินระดับความรู้สึกตัว ควรลืมตาได้กว้าง ประเมินการไอซึ่งควรไอได้แรง กำมือได้แน่น ยกศีรษะได้นานกว่า 5 วินาที
- สังเกตการแสดงออกหรือพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เช่น กระสับกระส่าย ไม่ทำตามคำสั่ง เป็นต้น
- สังเกตกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย เช่น ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น

ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

:ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

สาเหตุ:

- ก๊าซของยาระงับความรู้สึกทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดทั่วร่างกาย และกดศูนย์ควบคุมความร้อนของสมองส่วน Hypothalamus ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย
- ระยะเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายเป็นระยะเวลานาน
- การผ่าตัดขนาดใหญ่ที่มีการล้างแผลด้วยน้ำปริมาณมาก
- เพศหญิง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ

การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ

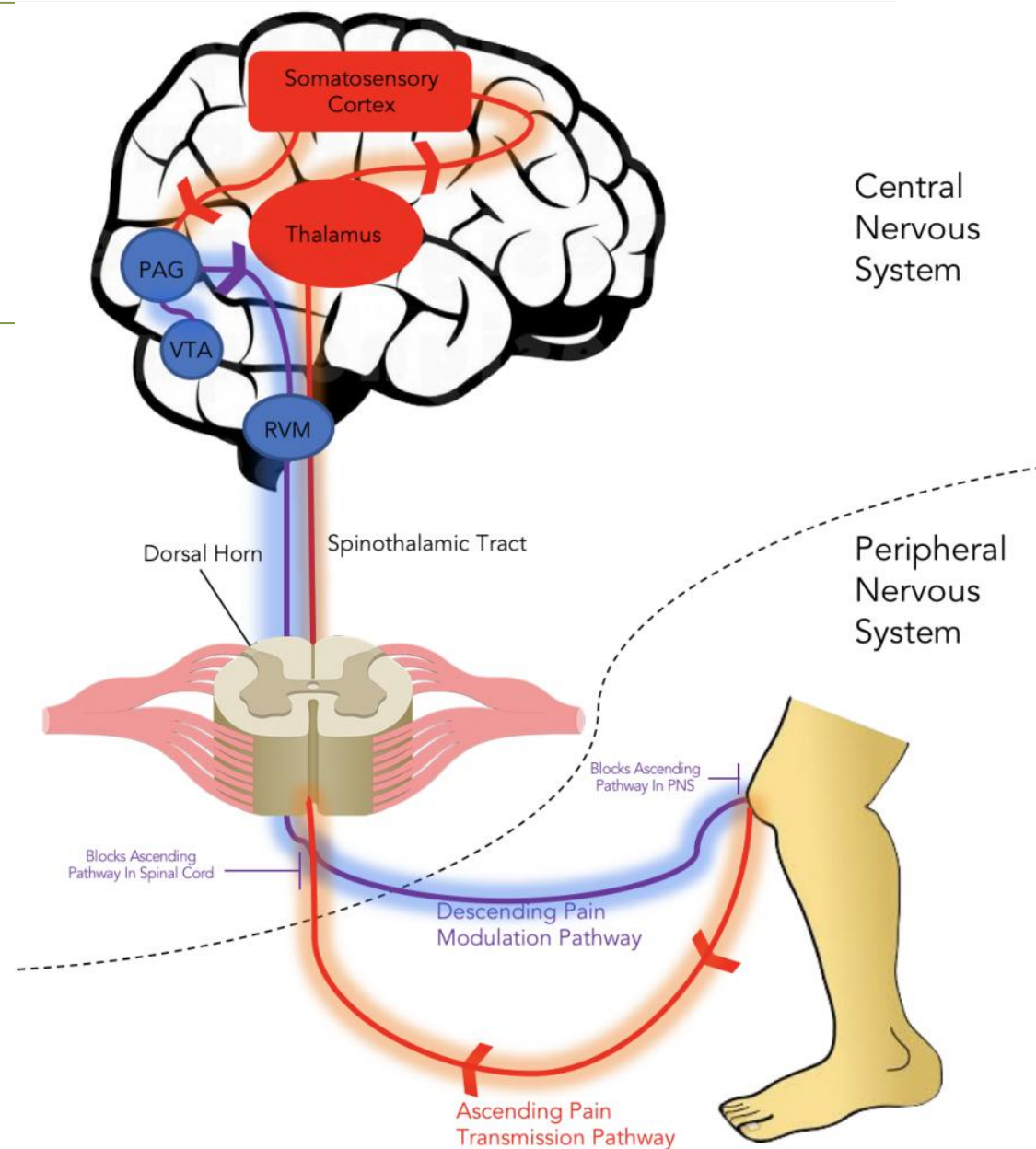


- ❖ ใช้ผ้าห่มอุ่นหรือผ้าห่มลมร้อนเพื่อ Keep warm ให้กับผู้ป่วย
- ❖ ก่อนให้สารน้ำและเลือดแก่ผู้ป่วยควรทำให้อุ่นก่อน
- ❖ ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการสั่น (Shivering) ควรรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาให้ยา Pethidine ทางหลอดเลือดดำ

ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การปวดแผลผ่าตัด

- ❖ การผ่าตัดทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และไปกระตุ้นใยประสาทขนาดเล็ก คือ A delta fibers และ C fibers ส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลัง แล้วจึงส่งสัญญาณไปที่สมอง ผู้ป่วยก็จะเกิดความรู้สึกปวด
- ❖ อาการปวดจะรุนแรงมากในระยะ 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
- ❖ ปัจจัยที่ทำให้อาการปวดรุนแรงขึ้น: มีท้องอืด หรือมีรีเฟลกซ์การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว อาการไอ ลักษณะของอาการปวดจะปวดลึก ๆ ตลอดเวลา

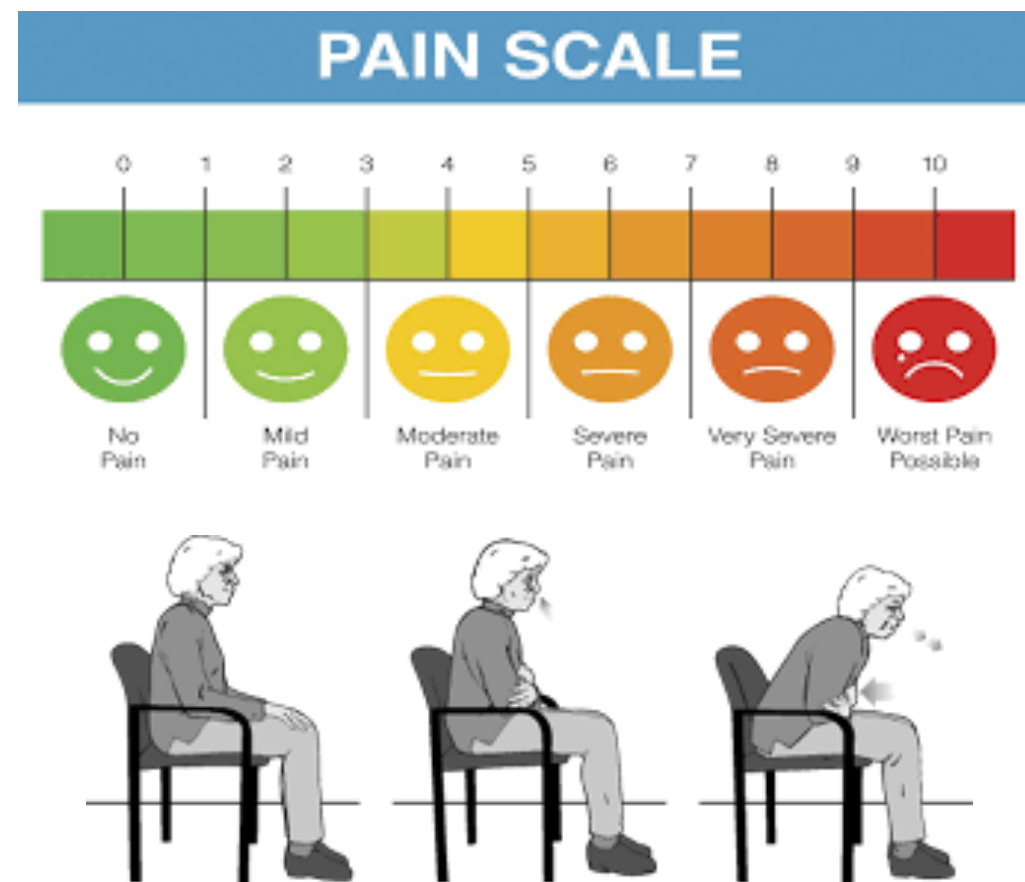


การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การปวดแผลผ่าตัด

- ❖ การประเมินความปวดโดยใช้เครื่องมือ : เครื่องมือที่ใช้ NRS, VRS
- ❖ การประเมินความปวดโดยอาการและอาการแสดง: การเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตและชีพจร ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ การแสดงออกทางสีหน้า อาการกระสับกระส่าย ร้องไห้
- ❖ ยาแก้ปวด: Opioid, NSAIDS
- ❖ ใช้มือทั้งสองข้างประคองแผลผ่าตัดหรือใช้หมอนวางทางบริเวณแผลผ่าตัดในขณะที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีอาการไอ

Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale

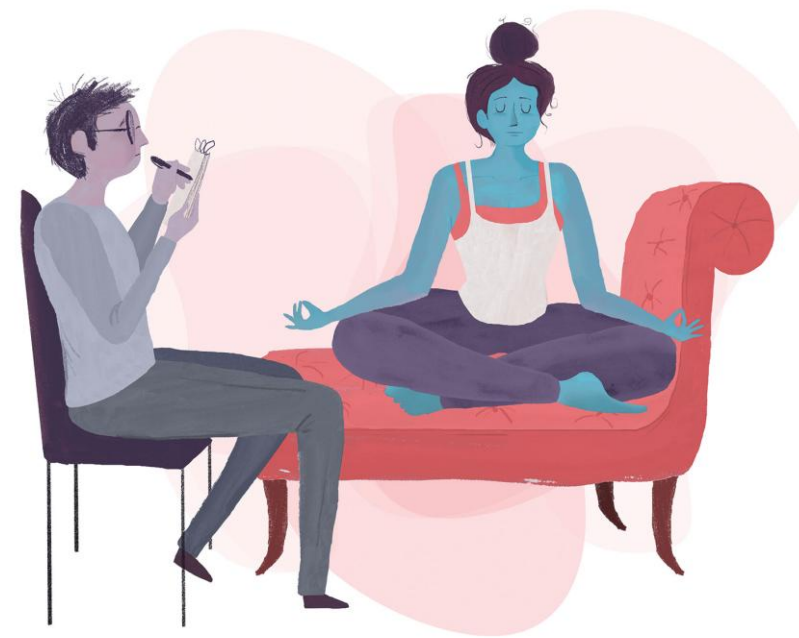


การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การปวดแผลผ่าตัด

การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยา

- การเปิดดนตรีบรรเลง : กระตุ้นต่อพิทูอิทารีให้หลั่งสารเอนดอร์ฟิน
- การทำสมาธิบำบัด : ผ่อนคลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย การเต้นของหัวใจความดันโลหิต และสารเคมีในสมอง เพิ่มการทำงานของ SG cell ปิดประตูกั้นสัญญาณความปวดไม่ให้ส่งไปที่สมอง
- เทคนิคการสร้างจินตภาพ : กระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวา เปลี่ยนแปลงการรับรู้ความปวดเป็นการรับรู้ภาพที่พึงพอใจแทน ลดการเร้าทางอารมณ์



การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การปวดแผลผ่าตัด

การจัดการความปวดโดยไม่ใช้ยา

- การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจ ระยะเวลา 15 นาที : กระตุ้นการทำงานของต่อมพิทูอิทารีทำให้มีการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน
- Aromatherapy ร่วมกับดนตรีบำบัด : ตามทฤษฎีการรับกลิ่น และกลไกการออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย ร่วมกับการฟังดนตรี บรรเลงเสียงธรรมชาติ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจทำให้อาการปวดลดลงได้
- ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวลเบามือ เพื่อลดการกระเทือนต่อบาดแผล



ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

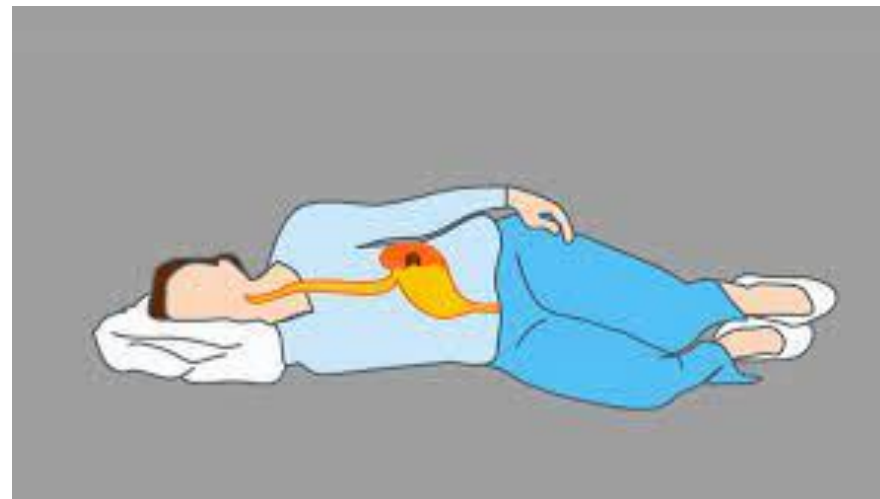
: ภาวะคลื่นไส้อาเจียน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะคลื่นไส้อาเจียน

- ผู้ป่วย ได้แก่ เพศหญิง อายุน้อย มีประวัติเมาเรือ เคยมีอาการเจียนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกครั้งก่อน เป็นไมเกรน การมีความเครียดและวิตกกังวล
- การได้รับยาระงับความรู้สึก พบว่าพบอุบัติการณ์ลดลงเมื่อได้รับยา Propofol ในการนำสลบ
- การผ่าตัด ได้แก่ ระยะเวลาในการผ่าตัดนาน การผ่าตัดทางตา การผ่าตัดอวัยวะ การผ่าตัดแบบส่องกล้อง การผ่าตัดเต้านม การผ่าตัดทางนรีเวช การผ่าตัดหูชั้นกลาง

การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด : ภาวะคลื่นไส้อาเจียน

- จัดตะแคงหน้าของผู้ป่วยไปด้านใดด้านหนึ่ง และดูดเอาเศษอาหารออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันการสำลักลงปอด
- ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนตามแผนการรักษาของแพทย์
- วิธีการกดจุด (Acupressure) และ TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation)



ปัญหาของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด

- เป็นภาวะแทรกซ้อนสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะหลังผ่าตัด ถึงแม้จะมีการโกนขน ฟอกผิวหนัง หรือทายาฆ่าเชื้อก่อนที่จะทำการลงมีดแล้วก็ตาม
- กลไกการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อมีแผลผ่าตัด กระตุ้นให้เกิดการอักเสบชนิดเฉียบพลัน (Acute inflammation) เกิดหลอดเลือดฝอยขยายตัว หลัง Neutrophil, Monocyte กลายเป็น Macrophage
- หากมีการติดเชื้อและแผลมีเนื้อตายมากก็จะเกิดการหายของแผลช้า
- การอักเสบในบาดแผลปกติจะเกิดได้นาน 4 วัน



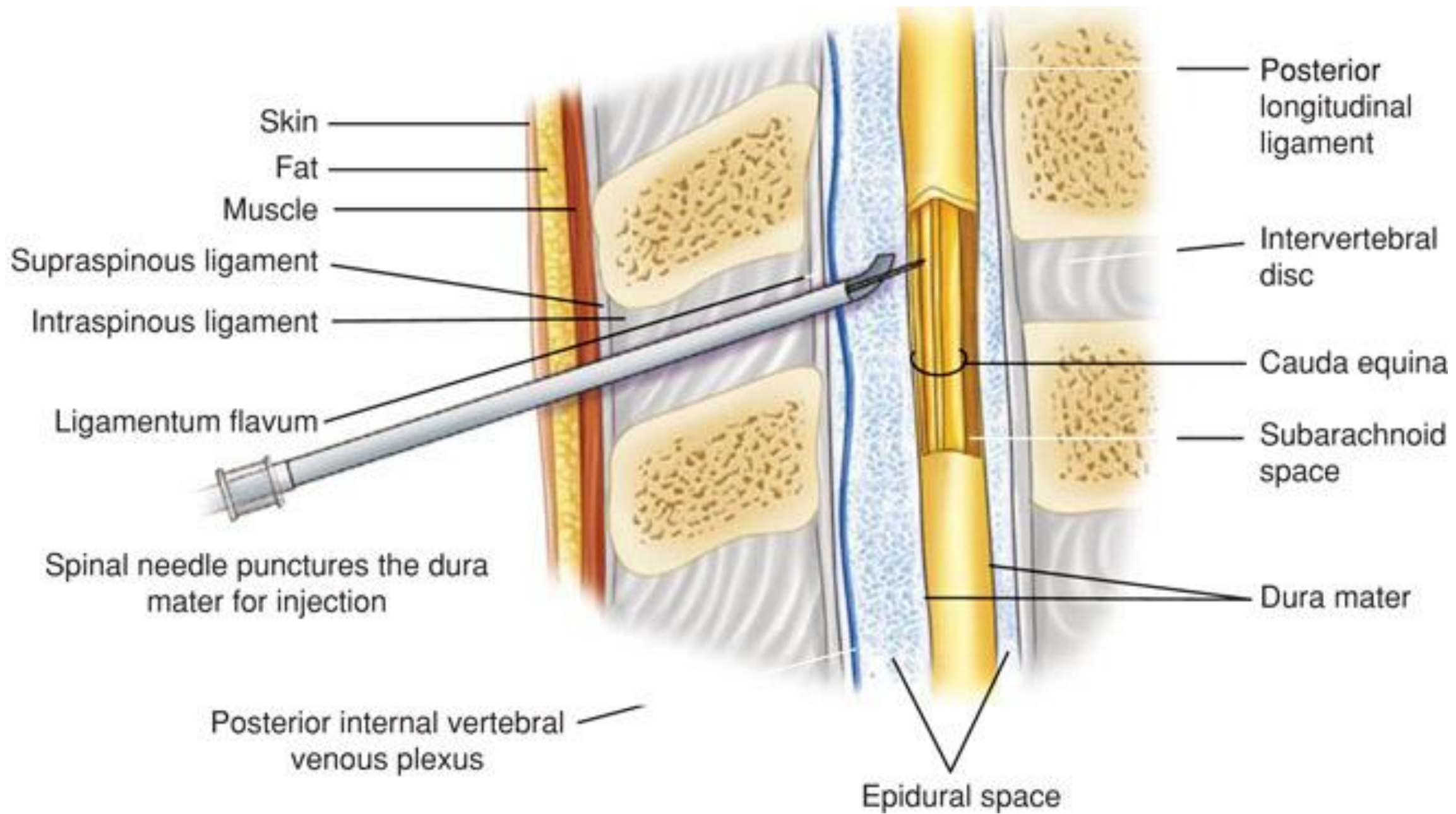
การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด : การติดเชื้อมีบริเวณแผลผ่าตัด

- การประเมิน: มีไข้ (มักมีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส) ปวด บวม แดง ร้อน หนอง มีกลิ่น HR เร็ว RR เร็ว เม็ดเลือดขาวสูง
- ดูแลแผล: ไม่ให้แผลเปียกน้ำ ไม่เกาแผล ทำแผลด้วยเทคนิคสะอาดปราศจากเชื้อ ดูแลการระบายของสิ่งคัดหลั่ง ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อม
- อาหาร: เน้นอาหารที่ส่งเสริมการหายของแผล เช่น โปรตีน วิตามินซี
- ATB: พร้อมสังเกตอาการข้างเคียงจากการให้ยา หรืออาการแพ้ยา

การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การพยาบาลผู้ป่วยหลังได้รับยาชาทางไขสันหลัง (Epidural หรือ Spinal anesthesia)

- หากได้รับยาทางช่องเหนือดูรา ให้ผู้ป่วยนอนราบ 4-6 ชม.
- หากได้รับยาทางช่องน้ำไขสันหลังให้นอนราบ 12-24 ชม. โดยหลังผ่าตัดให้ผู้ป่วยนอนราบหนุนหมอนได้แต่ห้ามลุกนั่ง เนื่องจากฤทธิ์ยาที่ให้ระงับความรู้สึกทางไขสันหลังนี้ จะทำให้ความดันโลหิตลดต่ำได้ บางครั้งอาจจำเป็นต้องพันขาด้วยผ้ายืด เพื่อป้องกันความดันโลหิตต่ำ
- ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำตลอดเวลาอย่างน้อย 4 ชม. หลังผ่าตัด เพราะหากมีอาการแทรกซ้อนหรือจำเป็นต้องให้ยาจะได้รับให้การรักษาอย่างทันท่วงที โดยที่หากมีความดันโลหิตลดลงควรให้สารน้ำเร็วขึ้น หากไม่ขัดต่อแผนการรักษา
- ป้องกันอันตรายจากการให้กระเป๋าน้ำร้อนหรือน้ำแข็งบริเวณส่วนล่างของร่างกาย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังตอบสนองได้ไม่ดี
- ดูแลผู้ป่วยกรณีที่อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เนื่องจากมีความดันโลหิตต่ำลงจากฤทธิ์ยาที่ใช้
- ดูแลผู้ป่วยกรณีที่อาจมีอาการปวดศีรษะภายหลังฉีดยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง (postdural puncture headache, PDPH)



การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้ Cervical block

ดูแลเรื่องการหายใจของผู้ป่วย โดยสังเกตและบันทึกสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะที่ได้รับยาชา อาจจะไปกด Phrenic nerve ทำให้เกิดอัมพาตของ hemi - diaphragm ได้

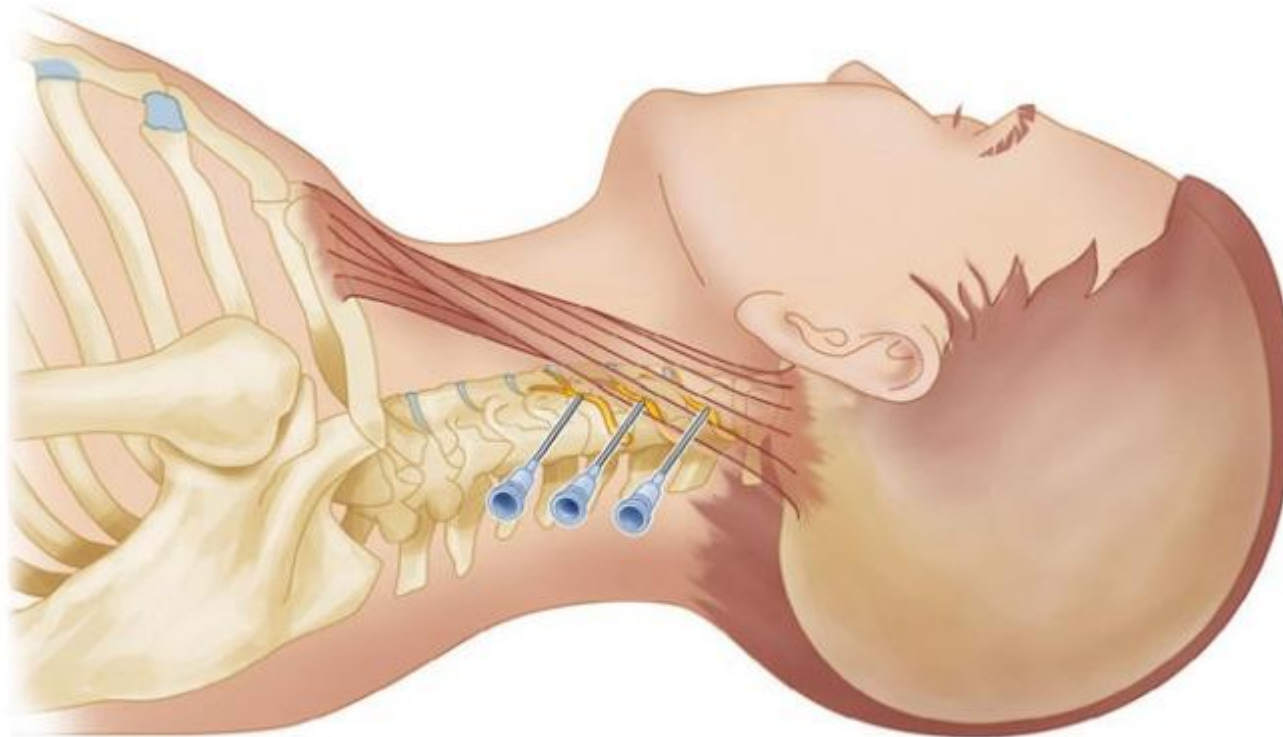
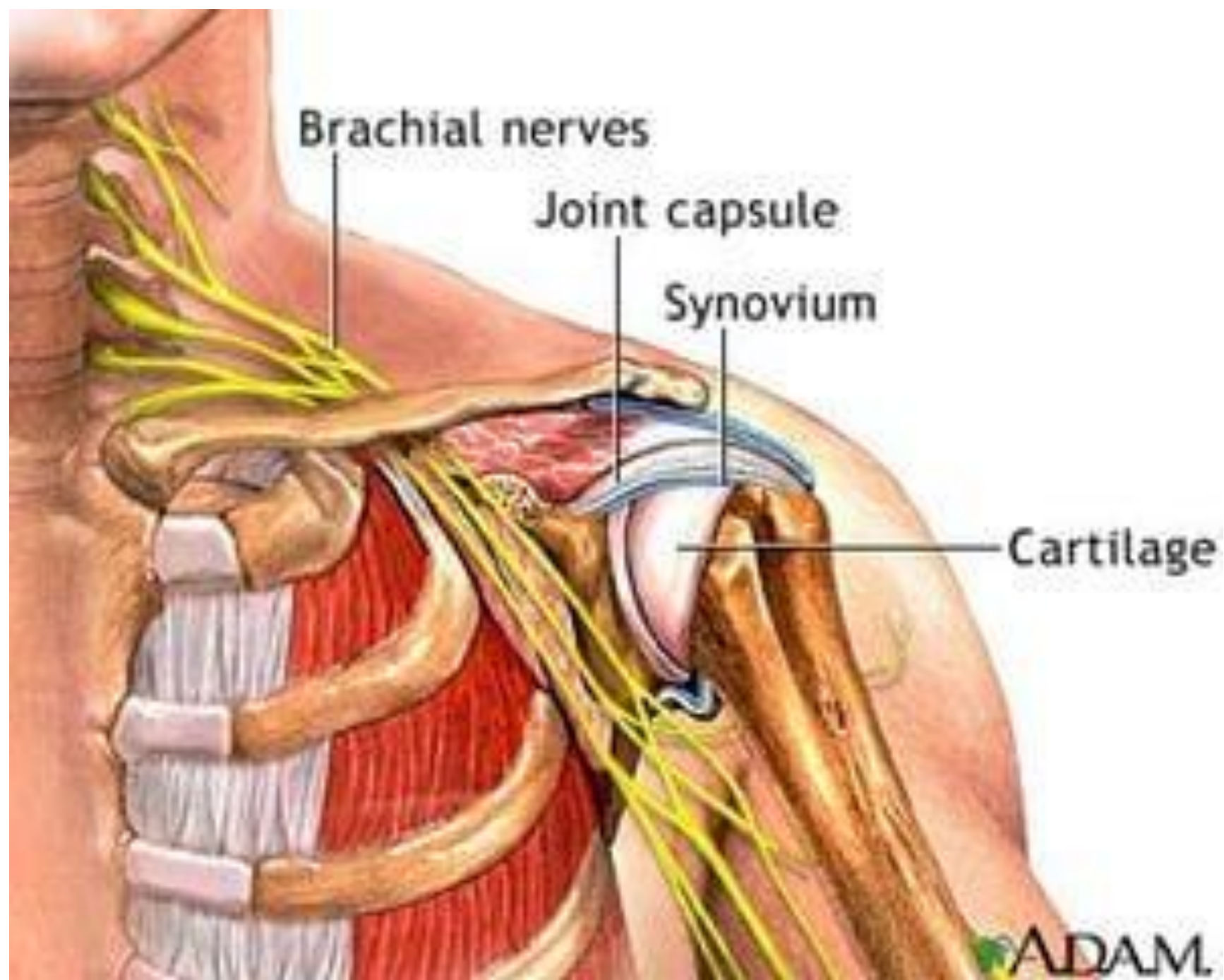


FIGURE 47-12 Cervical paravertebral nerve block.

การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้ Brachial block

- ❖ ดูแลเรื่องการหายใจของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะให้ยาชา ปลายเข็มอาจแทงถูกเยื่อหุ้มปอด ทำให้เกิดภาวะมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) ดังนั้นควรสังเกตอาการแน่น อึดอัด เจ็บหน้าอก หายใจหอบ
- ❖ หากไม่พบอาการผิดปกติใด ๆ แนะนำให้ผู้ป่วยใช้ผ้าคล้องคอ เพื่อป้องกัน brachial plexus ถูกดึงยืดออก ทำให้เกิด brachial palsy ได้

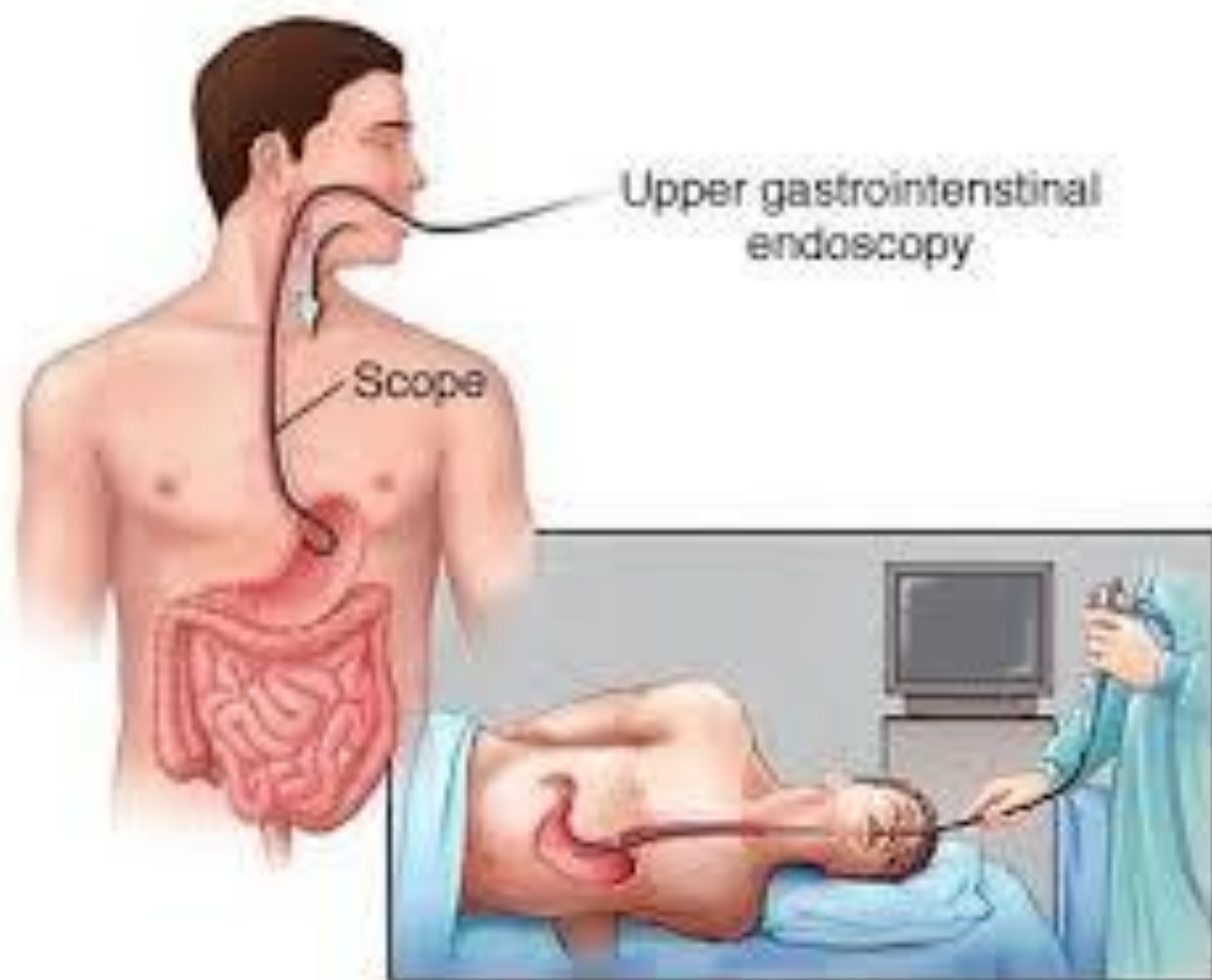


การพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด

: การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาชาในลำคอ (Topical anesthesia) และ ยาชาเฉพาะที่ (Local infiltration)

กรณีได้รับยาชาในลำคอ ควรให้ผู้ป่วยระมัดระวังการรับประทานอาหารและการสำลัก หากคอดังนี้ยังไม่หายชา ยังไม่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร

กรณีได้รับยาชาเฉพาะที่ ให้สังเกตอาการแพ้ยา หากไม่มีอาการสามารถให้ผู้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ทันทีหลังผ่าตัด



7.5 Postanesthesia Recovery Score (Modified Aldrete Score) ใช้ประเมินผู้ป่วยก่อนส่งกลับหอผู้ป่วย

Parameter observed	คะแนน	อาการ
Activity	0	ไม่สามารถขยับแขนขาได้เองหรือตามคำสั่ง
	1	ขยับเพียง 2extremities (แขนหรือขา)ได้เองหรือตามคำสั่ง
	2	ขยับทั้ง 4extremities (แขนและขา)ได้เองหรือตามคำสั่ง
Respiration	0	ไม่หายใจ
	1	หายใจลำบากหรือหายใจได้น้อย
	2	หายใจได้ลึก ไอได้
Consciousness	0	ไม่ตอบสนองเลย
	1	ตื่นเมื่อปลุก
	2	ตื่นดี รู้ตัวดี
Circulation	0	ความดันเลือดมากกว่า ± 50 มม.ปรอท จากค่าก่อนดมยา
	1	ความดันเลือด $\pm 20 - 50$ มม.ปรอท จากค่าก่อนดมยา
	2	ความดันเลือด ± 20 มม.ปรอท จากค่าก่อนดมยา
SpO ₂	0	SpO ₂ น้อยกว่า 90% แม้ได้ O ₂ อยู่
	1	ต้องการ O ₂ เพื่อรักษาระดับ SpO ₂ ให้มากกว่า 90%
	2	สามารถรักษาระดับ SpO ₂ ได้มากกว่า 92% เมื่อหายใจด้วย room air

Discharge จากห้องพักรฟื้นได้เมื่อ score 9 – 10(Aldrete JA. The postanesthesia recovery score revisited. J

ClinAnesth.1995;7:89.)

ขอบคุณจ้า

